



抗利尿激素分泌不当综合征 (SIADH)

作者: [James L. Lewis III](#), MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent's Ascension Health, Birmingham

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 6月 2025 | 修改的 7月 2025

在某些情况下，垂体不当地释放过多抗利尿激素（加压素）时，导致机体保水并通过稀释降低了血钠水平，此时会发生抗利尿激素分泌不当综合征。

(另见[电解质概述](#)和[钠在人体内的作用概述](#)。)

血管加压素（也称抗利尿激素 [ADH]）可通过控制肾脏排水量来帮助调节体内水量。加压素可减少肾脏排水量。因此，将更多水分保留在体内，这会稀释体内的钠。血钠水平低被称为[低钠血症](#)。

当血容量（血管内的液体量）或血压下降或电解质（例如钠）含量太高时，垂体会不当地生成和释放加压素。

如在以下情况发生，则视为血管加压素分泌不当：

- 血容量正常或偏高
- 血压正常或偏高
- [电解质浓度低](#)
- 不存在加压素释放的其他适当理由

如果加压素在这些情况下释放，则机体会保水过多，血钠水平会下降。

SIADH 的病因

许多情况增加了抗利尿激素异常分泌综合征发生的危险性。在垂体以外地方分泌加压素时，可能会发生 SIADH，正如某些肺癌和其他癌症中发生的一样。SIADH 常见于老年人和住院病人。

SIADH 的可能病因很多，通常需要额外检查才能发现。

表格

是什么原因导致SIADH?

疾病的类型

举例

疾病的类型	举例
大脑或神经系统	脑脓肿
	覆盖大脑的组织出血
	脑炎 （脑部发炎）
	格林巴利综合征
	头颅外伤
	下丘脑疾病，包括肿瘤（罕见）
	脑膜炎
肺	中风
	肿瘤
	急性呼吸
	肺炎
癌症	结核病
	脑癌
	肺癌
	淋巴瘤
	胰腺癌
其他	小肠癌症
	手术
营养不良	
SIADH=抗利尿激素异常分泌综合征。	

SIADH 的症状

SIADH 的症状常与伴随出现的[低钠血症](#)（血钠水平低）相关。症状包括反应迟缓、恶心、肌肉无力、感觉失衡和意识模糊。有些人有跌倒史。

SIADH 的诊断

- 血液和尿液检测

如果某人发生的低钠血症无法通过其他因素得到解释，例如疼痛、应激、剧烈运动以及心脏、甲状腺、肾脏或肾上腺存在某些可降低血容量并相应刺激垂体释放血管加压素的疾病，那么医生会疑诊 SIADH。

血液和尿液检查来检测钠离子和钾离子水平以及判断血液、尿液浓缩的程度。

一旦诊断出 SIADH，医生会尝试确定血管加压素过量的可能原因（如疼痛、压力、药物或癌症），并可能进行其他血液检查和影像学检查以查明原因。

SIADH 的治疗

- 限制液体摄入量

治疗包括限制液体摄入量和纠正病因。SIADH 患者需要长期[治疗低钠血症](#)。

有时静脉输液，包括输注钠浓度很高的液体（高渗盐水）。这种治疗必须谨慎进行，避免钠离子水平快速增加。

如果限制液体摄入后，血钠水平仍然继续下降或没有升高，则医生可能会开具能减弱血管加压素对肾脏的作用的药物（如地美环素或尿素），或可阻断血管加压素受体并防止肾脏对血管加压素产生反应的药物（如考尼伐坦和托伐普坦）。

氯化钠盐片可用于治疗持续性轻度至中度低钠血症，通常与液体限制和利尿剂一起使用。